Trutakna pri IgA nefropatii: finálna analýza ORIGIN 3 a význam pre prax

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia, nie mikroskopický nález. Cielená liečba sa posudzuje podľa toho, ako presne zasiahne mechanizmus ochorenia a čoho sa nedotkne.

Finálna analýza účinnosti štúdie ORIGIN 3, oznámená 15. septembra 2026, rozširuje poznatky o atacicepte (Trutakna, atacicept-vymj) pri primárnej IgA nefropatii. Popri predtým publikovanom znížení proteinúrie priniesla priaznivé výsledky odhadovanej glomerulovej filtrácie (eGFR) a kombinovaného ukazovateľa progresie. Septembrové údaje však zatiaľ pochádzajú z oznámenia zadávateľa a jeho prezentácie, nie z recenzovanej publikácie finálnej analýzy, ktorú by sme mohli overiť. [1, 2]

Stav poznatkov k 20. septembru 2026: treba odlíšiť recenzovanú priebežnú analýzu proteinúrie, novšie firemné výsledky a platnú americkú indikáciu. Každý z týchto zdrojov odpovedá na inú otázku.

Prečo blokovať BAFF a APRIL

Pri IgA nefropatii sa v mezangiu ukladajú imunokomplexy obsahujúce IgA a vzniká zápalové poškodenie glomerulov. Galaktózovo deficitný IgA1 (Gd-IgA1) je súčasťou tejto patogenetickej kaskády. Atacicept je rekombinantný fúzny proteín TACI-Fc, ktorý viaže cytokíny BAFF a APRIL. Tým zasahuje do signálov podporujúcich B-lymfocyty a tvorbu protilátok. Biologická vierohodnosť tohto mechanizmu sama osebe nenahrádza klinický dôkaz účinnosti. [3, 4]

Čo bolo schválené a prečo prišli výsledky skôr

FDA udelila lieku 7. júla 2026 zrýchlené schválenie na zníženie proteinúrie u dospelých s primárnou IgA nefropatiou ohrozených progresiou. Podkladom bol účinok na proteinúriu. Regulačný text naďalej uvádza, že dlhodobé spomalenie poklesu funkcie obličiek nebolo pre túto indikáciu stanovené a pokračovanie schválenia môže závisieť od potvrdenia klinického prínosu. [5, 6]

Rozdiel medzi pôvodne avizovaným rokom 2027 a septembrom 2026 má vysvetlenie: výrobca 2. júna 2026 oznámil dohodu s FDA o skoršej analýze eGFR. V septembri plánoval podať doplňujúcu žiadosť o plné schválenie vo štvrtom štvrťroku 2026. Pozitívne oznámenie výsledkov teda nemožno zamieňať za nové rozhodnutie FDA. [1, 7]

Populácia a priebežný výsledok proteinúrie

ORIGIN 3 je medzinárodná randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia fázy 3. Dospelí dostávali atacicept 150 mg podkožne raz týždenne alebo placebo v pomere 1 : 1. Recenzovaná priebežná analýza zahŕňala 203 pacientov: 106 s ataciceptom a 97 s placebom. V 36. týždni klesol pomer bielkovín ku kreatinínu v 24-hodinovom zbere moču (UPCR) oproti východisku o 45,7 % a 6,8 %. Relatívne zníženie oproti placebu podľa modelu geometrických priemerov bolo približne 42 %; nejde o jednoduché odčítanie uvedených percent. [3, 4]

Vstupné kritériá zahŕňali biopsiou potvrdenú IgA nefropatiu, eGFR ≥30 ml/min/1,73 m² a UPCR ≥1 g/g alebo proteinúriu ≥1 g/24 hodín pri stabilnej maximálne tolerovanej inhibícii renínovo-angiotenzínového systému. Súbežná stabilná liečba inhibítorom SGLT2 bola povolená. Tieto kritériá opisujú skúmanú populáciu; nemožno ich automaticky vydávať za úplné znenie schválenej indikácie. [4]

Finálna analýza: funkcia obličiek a progresia

Nasledujúce výsledky výrobca uviedol pre analytický súbor 428 pacientov. Hodnoty v tabuľke sú prevzaté z primárneho firemného hlásenia v SEC, nie zo sekundárneho mediálneho súhrnu. [1]

Ukazovateľ	Atacicept	Placebo	Rozdiel alebo pomer rizík (95 % IS)
Zmena eGFR v 52. týždni (ml/min/1,73 m²)	−0,1	−5,7	5,6 (3,7 až 7,5)
Ročné tempo zmeny eGFR do 104. týždňa (ml/min/1,73 m²/rok)	−0,6	−5,6	5,0 (3,6 až 6,5)
Kombinovaný ukazovateľ progresie do 104. týždňa	11 udalostí	38 udalostí	HR 0,24 (0,12 až 0,48)

Pre všetky tri porovnania výrobca uviedol $p < 0,0001$. IS znamená interval spoľahlivosti; HR je pomer okamžitých rizík. Hodnota −0,1 v 52. týždni je zmena od východiska, kým −0,6 je odhad ročného tempa zmeny počas sledovania do 104. týždňa. Ide o odlišné veličiny. [1]

Kombinovaný ukazovateľ zahŕňal prvý výskyt úmrtia, transplantácie obličky, dialýzy trvajúcej ≥30 dní, eGFR <15 ml/min/1,73 m² pretrvávajúcej ≥30 dní alebo poklesu eGFR o ≥30 % pretrvávajúceho ≥30 dní. [2]

Zníženie o 76 % sa týka kombinovaného ukazovateľa, nie samotnej úmrtnosti. HR 0,24 tiež neznamená absolútne zníženie rizika o 76 percentuálnych bodov. Súhrn dialýzy trvajúcej ≥30 dní, transplantácie alebo úmrtia predstavoval 0 oproti 8 udalostiam. Bez samostatného spoľahlivého vyhodnotenia jednotlivých zložiek nemožno tvrdiť, že liek preukázateľne znižuje úmrtnosť súvisiacu s obličkami. [1]

Čo znamená sledovanie do dvoch rokov

V grafe eGFR výrobcu malo v 104. týždni dostupné meranie 50 pacientov s ataciceptom a 37 s placebom, hoci každé rameno analytického súboru zahŕňalo 214 pacientov. Ročný sklon bol odhadnutý zmiešaným modelom s náhodným interceptom a sklonom. [2]

Označenie „dvojročné výsledky“ preto neznamená, že všetkých 428 pacientov dokončilo dva roky liečby. Samotný menší počet neskorých meraní nepreukazuje vysoký počet predčasných ukončení; súvisieť môže aj s priebežným náborom a skorším dátovým uzáverom. Na definitívne posúdenie treba úplné údaje o dĺžke sledovania, chýbajúcich meraniach, cenzorovaní a analýzach citlivosti. Stabilizácia priemernej eGFR navyše nie je dôkazom vyliečenia ani zárukou individuálnej odpovede.

Bezpečnosť: celkový súhrn nestačí

Vo finálnom bezpečnostnom súbore výrobca hlásil nežiaduce udalosti u 75 % oproti 78 % a infekcie u 51 % oproti 52 % pacientov. Reakcie v mieste vpichu však boli častejšie pri atacicepte: 25 % oproti 7 %. Ide o údaje z neskoršieho hodnotenia, ktoré netreba miešať s kratšou expozíciou v pôvodných registračných podkladoch. [2]

Americká preskripčná informácia upozorňuje na infekcie, odporúča odložiť začatie pri aktívnej infekcii a pri závažnej infekcii zvážiť prerušenie liečby. Kontraindikáciou je závažná precitlivenosť na liečivo alebo pomocné látky. [4] Pred liečbou sa majú doplniť očkovania primerané veku; živé vakcíny sa neodporúčajú počas 30 dní pred začatím ani počas liečby. Súbežné imunomodulačné lieky môžu zvýšiť infekčné riziko a ich kombinácia nebola vyhodnotená. [8]

Význam pre nefrologickú prax

Výsledky podporujú potenciál ataciceptu ovplyvniť priebeh ochorenia nad rámec samotného zníženia proteinúrie. Ich praktická interpretácia však musí zohľadniť výber pacientov, sprievodnú liečbu, trvanie sledovania a dostupnosť úplnej analýzy. Porovnanie s placebom neumožňuje vyhlásiť atacicept za účinnejší než iné cielené lieky bez priameho porovnania.

Rozhodnutie FDA platí pre USA a samo osebe nedokladá registráciu, dostupnosť ani úhradu na Slovensku. Pri klinickom rozhodovaní treba vychádzať z aktuálne platných miestnych podmienok a schválenej informácie o lieku.

Finálna analýza oznámená zadávateľom priniesla priaznivý signál zachovania eGFR a nižšieho výskytu kombinovanej progresie. Samostatný prínos pre úmrtnosť, dlhodobá ochrana pred dialýzou a úplné regulačné potvrdenie týchto nových výsledkov sa z tohto oznámenia nedajú automaticky vyvodiť.

Súvisiaci článok: Atacicept pri IgA nefropatii: pôvodné zrýchlené schválenie FDA a proteinúria.

Zdroje

1. *Vera Therapeutics. Form 8-K, 15. 9. 2026, časť 8.01. Primárne hlásenie finálnych výsledkov.*
2. *Vera Therapeutics. Corporate Presentation, september 2026, snímky 23 až 25. Príloha 99.2 k hláseniu SEC.*
3. *Richard Lafayette, Sean J. Barbour, Robert M. Brenner, Kirk N. Campbell, Tom Doan, Necmi Eren, Jürgen Floege, Vivekanand Jha, Beom Seok Kim, Adrian Liew, Bart Maes, Atanu Pal, Roberto Pecoits-Filho, Richard K. S. Phoon, Dana V. Rizk, Hitoshi Suzuki, Vladimir Tesař, Hernán Trimarchi, Xuelian Wei, Hong Zhang, Jonathan Barratt; ORIGIN Phase 3 Trial Investigators. A Phase 3 Trial of Atacicept in Patients with IgA Nephropathy. N Engl J Med. 2026;394:647–657. Elektronicky 6. 11. 2025. DOI: 10.1056/NEJMoa2510198. PubMed, overený zoznam autorov a abstrakt.*
4. *FDA. TRUTAKNA, Prescribing Information, júl 2026, oddiely 4, 5, 11 a 14. Úplná americká preskripčná informácia.*
5. *FDA. FDA Approves New Treatment to Reduce Proteinuria in Adults with Primary Immunoglobulin A Nephropathy. Schvaľovacie oznámenie.*
6. *FDA. Purple Book, Trutakna, BLA 761486. Dátum prvého schválenia.*
7. *Vera Therapeutics. Announces Alignment with U.S. FDA on Earlier ORIGIN Phase 3 Analysis, 2. 6. 2026. Zmena harmonogramu analýzy.*
8. *Vera Therapeutics. Oznámenie finálnej analýzy ORIGIN 3, 15. 9. 2026, vrátane bezpečnostnej informácie. Príloha 99.1 k hláseniu SEC.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=trutakna-atacicept-iga-nefropatia-origin-3-finalna-analyza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.